

Fecha Última Actualización: 27-06-2022 0:57:37

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Cecilia Magdalena Ramirez Catalan
Edad : 66a 10m 5d
Dirección : Pje El Escudo 0777 Cielo Andino

Rut : 8.136.092-8
Fecha Nacto: 22/08/1955
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A680189
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4415 7606

N° Epicrisis
312864

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 18/06/2022 06:07

Días Estadía : 9

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 27/06/2022 00:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

- Shock Hipovolémico Hemorrágico
- HDA por ulcera duodenal Forrest IA - hemostasia Spray (ABGIO TC no embolizable) ¿ VEDA control x re sangrado 24/6 (2da porción duodenal Ulcera Forrest III)
- DHC NASH - Varices esofágicas
- Fallo Multi orgánico (hemodinámico/coagulopático/plaquetopenia/hematológico/metabólico)
- FA ¿ CVE (19/6)
- Insuficiencia Respiratoria (Infecciosa/EPA/TRALI) - SDRA Severo ¿ refractario a PRONO x2 (20-22/6 24-24/6)
- Fallo Renal IRA KDIGO 3 ¿ TRR (Fi 26/6) - SLED
- SHOCK Séptico Refractario (Vasopresina) ¿ inicia VANCO / MERO (25/6)

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

DIAGNOSTICOS

- Shock Hipovolémico Hemorrágico
- HDA por ulcera duodenal Forrest IA - hemostasia Spray (ABGIO TC no embolizable) ¿ VEDA control x re sangrado 24/6 (2da porción duodenal Ulcera Forrest III)
- DHC NASH - Varices esofágicas
- Fallo Multi orgánico (hemodinámico/coagulopático/plaquetopenia/hematológico/metabólico)
- FA ¿ CVE (19/6)
- Insuficiencia Respiratoria (Infecciosa/EPA/TRALI) - SDRA Severo ¿ refractario a PRONO x2 (20-22/6 24-24/6)
- Fallo Renal IRA KDIGO 3 ¿ TRR (Fi 26/6) - SLED
- SHOCK Séptico Refractario (Vasopresina) ¿ inicia VANCO / MERO (25/6)

EVOLUCION

Paciente al momento en estado critico ¿ pronostico ominoso, cursando FALLO MULTIORGANICO. Bajo sedoanalgesia SAS 1, ventilando en IOT/ARM VCA 100% - Pafi 98 cursando SDRA severo refractario ¿ sin respuesta a PRONO (x 2 previos), hemodinámicamente inestable con requerimiento de vasopresores en altas dosis (noradrenalina 0.9 ¿ Vasopresina 0-04), Fallo renal (BUN 26) que inicio TRR 1600ml (descenso) ¿ Bal acumulado 11lts, Fallo hepático en ascenso BT 27 BD 13, Coagulopatía RIN 5.46 / KPTT 62. Bicitopenia Hto 24/Hb 8 ¿ Plaquetas 32000, con lesiones hemorrágicas externas (piel / ocular), sin signos de melenas ¿ sin SNG. Desde lo Infectológico con cultivos abierto y tto ATB empírico (Meropenem/Vancomicina).

Se recibe paciente en mal estado muy grave , posteri a esto inestable sin respuesta a DVA .

Fecha Epicrisis : 27/06/2022 00:57

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 27-06-2022 0:57:37

Página 2 de 2

See constata hora fallecimiento a las 00:05 . se avisa a familiares .

Diagnóstico de Egreso

Shock septico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallecido

-

falla multiorganica

shock refractario

Plan Post Alta

se entrega certificado defunion

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



José Joaquín García Haro
Médico Tratante (Staff)